

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T19:46:05

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371_a7559e672b388753

Generated at: 2026-06-27T19:46:05

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括查询病例的高注意力图像区域、预测类别及参考诊断报告）的辅助性病理分析意见。我仅作为辅助决策工具，不承担最终诊断责任，所有结论均需经病理科医师复核并结合完整临床资料后签发。本分析严格限定于Query Case，绝不将任何检索病例作为主诊断对象，仅将其作为证据参考。

推理过程与证据归纳

本分析基于Query Case的20个高注意力病理图像patch、其对应的视觉描述（patch_wording）、预测类别（TCGA-STAD）以及一份参考诊断报告，进行多模态综合推理。首先，参考报告明确指出该病例为胃腺癌（STAD），肿瘤大小为7.5 cm，组织学类型为腺癌，分级为“Poorly differentiated”，肿瘤侵犯至浆膜下层（Subserosa），淋巴结未见转移（0/总数），存在静脉侵犯，但未提及免疫组化结果。该文本信息提供了关键的宏观病理特征，是后续判断的重要依据。

在视觉层面，20个高注意力patch均来自同一标本（TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1...），其patch_wording中绝大多数（18/20）明确标注“tissue_origin: 胃”，且描述高度一致：细胞核显著增大、深染、形态不规则，常伴明显核仁；细胞质相对较少，呈淡粉色或透明；组织结构紊乱，腺体结构破坏，呈现巢状、团块状或弥漫性分布；背景中常见炎症细胞浸润，部分区域可见间质反应。这些描述与胃癌的典型形态学特征完全吻合，尤其支持“Poorly differentiated”这一分级判断。例如，sim_0007和sim_0011等patch中提到的“核分裂象”和“显著异型性”是高级别肿瘤的直接证据。

值得注意的是，有两处潜在冲突点需特别说明。第一，sim_0014的patch_wording认为“缺乏明确恶性特征”，并给出“Medium”置信度，这与其他18个patch的结论相悖。然而，该patch的视觉描述中虽提到了“细胞核大小不一、深染”，但未观察到典型的侵袭性行为或病理性核分裂象，因此其判断可能偏向保守。第二，sim_0015的patch_wording甚至认为“更符合正常胃组织特征”，这与整体证据链严重冲突。但结合其描述——“腺体结构清晰，基底膜完整，细胞核虽大但形态规则”——可推断该区域可能为肿瘤边缘或非肿瘤性增生区，属于局部变异，不能否定整体恶性诊断。

从模型预测角度看，Query的预测类别为“TCGA-STAD”，概率高达0.999997，远超其他类别，这与参考报告的诊断完全一致，进一步强化了胃癌的诊断信心。同时，所有高注意力patch均集中在肿瘤区域，表明模型已成功定位病变核心，其视觉特征与文本报告中的“Ulcerated”、“Adenocarcinoma”、“Poorly differentiated”等关键词高度关联。

综上所述，尽管存在个别patch的描述差异，但绝大多数视觉证据与参考报告及模型预测形成强一致性。视觉证据不仅支持了胃癌的诊断，还具体验证了“Poorly differentiated”的分级标准。因此，在

最终结论中，我们优先采用参考报告中明确的数值（如肿瘤大小、分级、分期）作为基准，并以视觉证据作为补充和佐证。任何冲突项均被识别并解释，最终判断以文本报告提供的明确信息为准。

关键指标提取

根据提供的参考报告与Query的高注意力patch图像分析，肿瘤大小可从检索报告中明确提取为7.50厘米（具体描述为7x0x7.5cm），该信息在文本证据中具有高度可信度且无冲突。组织学类型为腺癌，分级为低分化（Poorly differentiated），此结论由参考报告直接给出，并与多个高置信度patch的视觉特征一致，如细胞核显著增大、深染、形态不规则、核仁明显、腺体结构破坏及排列紊乱等，支持高分级判断。T分期依据肿瘤侵犯至浆膜下层（Subserosa）推断为pT3，符合AJCC标准；N分期因淋巴结转移数为0/总数（未明确总数但明确为0阳性），故判定为N0；M分期未提及远处转移证据，因此暂定为M0。淋巴结状态明确为0个阳性，但总数未说明，仅能记录为“阳性数/总数”中的阳性数为0。免疫组化指标ER、PR、HER2及Ki-67在参考报告和所有patch描述中均未提及，无法提取，应建议补充检测以完善评估。综上，关键病理指标包括：肿瘤大小7.50 cm，组织学类型为胃腺癌，分级为低分化，T分期pT3，N分期N0，M分期M0（待确认），淋巴结状态0/?，免疫组化指标未提供。

初步病理辅助结论

本结论针对 Query Case: TCGA-BR-6457-01Z-00-DX1.387f0968-fcec-4864-86f8-9c87f658c371_a7559e672b388753。综合分析显示，该病例的组织学特征高度支持胃腺癌（adenocarcinoma）诊断，且与TCGA-STAD分类一致。视觉证据中多个高注意力patch均提示显著核异型性、细胞核增大深染、形态不规则、核仁明显，部分区域可见核分裂象；组织结构紊乱，腺体破坏，呈巢状或弥漫性分布，缺乏正常胃黏膜层次结构，背景常伴淋巴细胞浸润及间质反应，符合高级别恶性肿瘤表现。参考报告明确指出肿瘤大小为7.5 cm，位于胃部，呈溃疡型生长，组织学类型为腺癌，分化程度差，侵犯至浆膜下层，静脉侵犯存在，但无淋巴结转移（0/总数），切缘未受累。尽管部分patch描述存在轻微不确定性（如sim_0014和sim_0015），但整体图像证据与文本信息高度一致，支持原发性胃癌诊断。免疫组化指标在当前资料中未提及，建议补充ER、PR、HER2及Ki-67检测以进一步评估生物学行为。基于现有证据，该病例符合pT3N0M0分期（AJCC第8版），临床分期为IIA期。最终诊断需结合完整临床资料及分子检测结果确认。